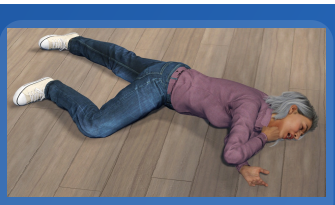
שינויים במצב ההכרה

הגדרות · גורמים: MIND VT · בדיקה ואנמנזה · פרוטוקול מד"א

דף סיכום · פודקאסטים קלוד



מה זה, ואיך זה נראה?

ההגדרה

מטופל **שלא בהכרה מלאה**: מתחת ל-**A** (לא ער וערני), או **GCS מתחת ל-14**.

שלושה גורמים עיקריים

↓ אספקת **דם** למוח · ↓ אספקת **אנרגיה** למוח · ↓ **תפקוד** מוחי. ולכל אחד מהם המון סיבות.

מושגים

ערות: מודע לעצמו ולסביבה ומגיב · **שינה:** חוסר הכרה טבעי · **בלבול:** בהכרה, אבל תפיסה, זיכרון והתמצאות נפגעים · **דליריום:** בלבול אקוטי עם אי שקט, בעיקר מטבולי או טוקסי (אלכוהול, תרופות, סמים, חום, פסיכיאטרי).

לתרגיה	סטופור	מצב צמחי	שטחי	תרדמת	עמוקה
רדום כל עוד אין גירוי	מגיב רק לגירוי חזק	ער וזז, לא מודע	רוב הרפלקסים קיימים	אין מוטוריקה, מגיב לכאב	לא מגיב לשום גירוי

לתרגיה וסטופור: בשניהם **הגירוי מחזיק את האדם ער**. ברגע שמפסיקים, הוא שוקע בחזרה.

בשטח: ככל שהמטופל עמוק יותר, **נתיב האוויר והנשימה** בסכנה גדולה יותר. בתרדמת שמגיב לכאב: יצטרך תרופות הרדמה לטובוס.

אנמנזה

בשטח: נשיכת לשון וסוגרים בבדיקה ← לחשוב על פרכוס. כל ממצא מכוון לאות ב-MIND VT.

מה שואלים (בעיקר את הסביבה)?

מה קדם · מחלות רקע ותרופות · **המצב ההכרתי הבסיסי** · האם גירוי משפר · נפילות וחבלות לאחרונה · **מתי התחיל**. מחפשים את **השינוי** (בדמנציה בלבול יכול להיות רגיל).

שימו לב: נוגדי קרישה + חבלה קלה לפני כמה ימים ← דימום מתחת לקרום הקשה, עם הידרדרות איטית בהכרה.



בדיקה: ABCDE

מה מחפשים בכל אות?

A הפרשות או גוף זר · **B** ציאנוזיס, קפנומטריה, האזנה, דפוס נשימה · **C** לחץ דם, דופק פריפרי, צבע וחום העור, מילוי קפילרי · **D** אישונים, נשיכת לשון, סוגרים, סוכר, חסר נוירולוגי · **E** חבלות, משאבת אינסולין (לנתק), מדבקות פנטניל (להסיר), בצקת או פריחה.

בשטח: **סוכר ואישונים לכל מטופל** עם שינוי בהכרה.

גורמים: MIND VT

M · מטבולי: היפו/היפרגליקמיה, אלקטרוליטים, היפרוונטילציה, היפותרמיה. **I · זיהומי:** מחלות חום. **N · נוירולוגי:** שבץ, פרכוס, גידול במוח, פגיעת ראש, דמנציה, מצבים פסיכיאטריים, ואפילו שינה. **D · תרופות:** מינון יתר, אלכוהול, סמים, הרעלת אופיאטים. **V · כלי דם ונשימה:** הלם (כולל שוק קרדיוגני), אי ספיקה נשימתית. **T · טראומה וטמפרטורה:** פגיעת ראש, היפותרמיה, היפרתרמיה.

טיפול ופרוטוקול מד"א

מד"א: שינויים במצב ההכרה (אוגדן עמ' 86)

1. נתיב אוויר, על הצד (הריון: צד שמאל)
2. שקול חמצן (סטורציה מעל 92%) · עירוי · תשאול ובדיקה · סוכר
3. היפוגליקמיה (מתחת ל-60 mg% עם תסמינים)? ← שקול גלוקוג'ל 15 גרם לפה, או גלוקוז 25 גרם IV 25%
4. חשד לאופיאטים (ירידה בהכרה, דיכוי נשימתי, אישונים צרים)? ← נרקן
5. לא, או אין שיפור ← גורמים אחרים · מדדים כל 5–10 דק' · שקול דיווח מקדים · פינוי דחוף

לאף	לווריד	10 mg
עד 2 mg · מנות של 0.4 mg	0.4–2 mg · מהול ב-10 ml · לאט	מקסימום מצטבר

שימו לב: נרקן: המטרה **לשפר את הנשימה**, לא בהכרח להעיר. אישונים תקינים **לא שוללים** אופיאטים.

3 דברים לזכור

1. **סוכר ואישונים לכל מטופל עם שינוי בהכרה**
2. **MIND VT: כדי לא לפספס אף גורם**
3. **נרקן: לשפר נשימה, לא בהכרח להעיר**

מקור: התסריט של הסרטון (מצגת הקורס ואוגדן ALS מד"א עמ' 87–86). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. איורים מוויקישיתוף: Grummelbacke · Scientific Animations (מעובד). רישיונות: CC0 ו-CC BY-SA 4.0.